

Formula hazırlanması Tamamlayıcı beslenme

PROF. DR. NURSAN ÇINAR
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

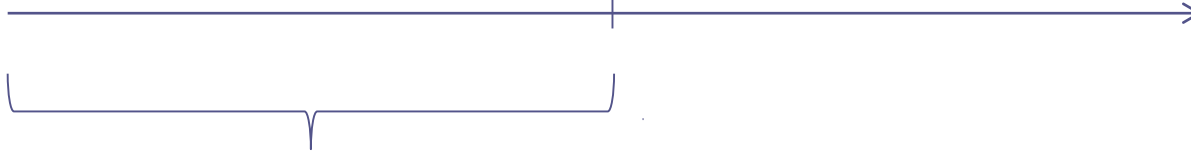
Sunum-II

İçerik

- Giriş
 - Yapay beslenme
 - Formula hazırlamada dikkat edilmesi gerekenler
 - Karışık beslenme
 - Tamamlayıcı Beslenme
- 1-3 yaş çocuk beslenmesi

Doğum

1 yaş



KRİTİK DÖNEM



- *mikro ve makro besin ihtiyacının yüksek olduğu (büyümeye bağlı)
- *beyin gelişimin %90'ının tamamlandığı
- *bağırsak mikrobiyotasının erişkin halini aldığı
- *yeme davranışının geliştiği +

ERİŞKİN DÖNEM
SAĞLIĞININ
BELİRLEYİCİSİ

- Süt çocukluğu dönemindeki besin eksikliği çocukluk ve erişkin dönemdeki sağlıkla da ilişkilidir.



Hedef boyun kısa olması

Entelektüel performansın daha düşük olması

Kardiovasküler hastalıklar

Tip 2 diyabet

Hipertansiyon

Obezite

DOĞAL BESLENME- ANNE SÜTÜ

- Bebeğin sağlıklı olabilmesi ve hayatta kalabilmesi için doğumdan sonra tutunduğu ilk dal **ANNE SÜTÜDÜR.**



DOĞAL BESLENME- ANNE SÜTÜ

- İlk 6 ay tek başına ANNE SÜTÜ-tamamlayıcı besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine kadar anne sütünün devamı önerilmektedir.



Ancak dünyada ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenme istenilen orana ulaşmamıştır.

YAPAY BESLENME

- İnek sütü ya da formül sütlerle (Adapte ve yarı adapte formüla, devam formülaları) yapılan beslenmeye yapay beslenme adı verilir.
- Bebek veya anneye ait sorunlar nedeniyle anne sütü verilememe durumunda uygulanan beslenme şeklidir.





Formül mama verilme kararı

- Endikasyon hekim tarafından belirlenmeli
- Biberon dışı yöntemlerle verilmelidir
- Mümkün olan en kısa sürede kontrollü bir şekilde tek başına emzirmeye dönmek hedeflenmelidir

İlk altı ay anne sütü

Formulanın Doğru Hazırlanmasının Önemi

- Formula besinlerin doğru hazırlanması bebeklerin sağlığı ve iyiliği açısından şarttır. Formulayı doğru bir şekilde hazırlayabilmek için ebeveynler veya bakıcılar formulayı hem doğru hem de hijyenik hazırlamak zorundadır. Bebek formulası genellikle piyasada üç şekilde bulunur:
 - kullanıma hazır formula
 - sıvı konsantre
 - toz halinde bebek formulası

- Bebek formulası genellikle piyasada üç şekilde bulunur:
- Kullanıma hazır formula
- Sıvı konsantre
- Toz halinde bebek formulası

- Kullanım öncesinde toz halindeki formülaların temiz suyla uygun miktarda seyreltilmesi gerektirir.
- Formula fazla seyreltilirse yetersiz kalori ve besin maddesi alımına neden olabilir. Formula çok konsantre ise dehidrasyon, diyare ve aşırı kalori alımına yol açarak aşırı kilo veya obeziteye neden olabilir.

- Hem toz hem de suyun ölçümü için doğru ölçü araçlarının kullanılmalıdır.

- Bebek formulasının hijyenik olmayan koşullarda sulandırılması zararlı bakterilerin üremesi için ideal koşulları hazırlar.
- Formula hazırlarken kullanılan kaşık ve blenderlar gibi kontamine mutfak aletlerinin kullanılması enfeksiyon riskini artırır.

- Bebek formulasıyla beslenmede en önemli madde formulanın kendisidir. Formulayı kullanmadan önce tenekenin etiketi, kapağı veya altındaki son kullanma tarihini kontrol edilmelidir.
- Son kullanma tarihi geçtiyse, bebek formulasının süresi dolmuştur ve kullanılmamalıdır.

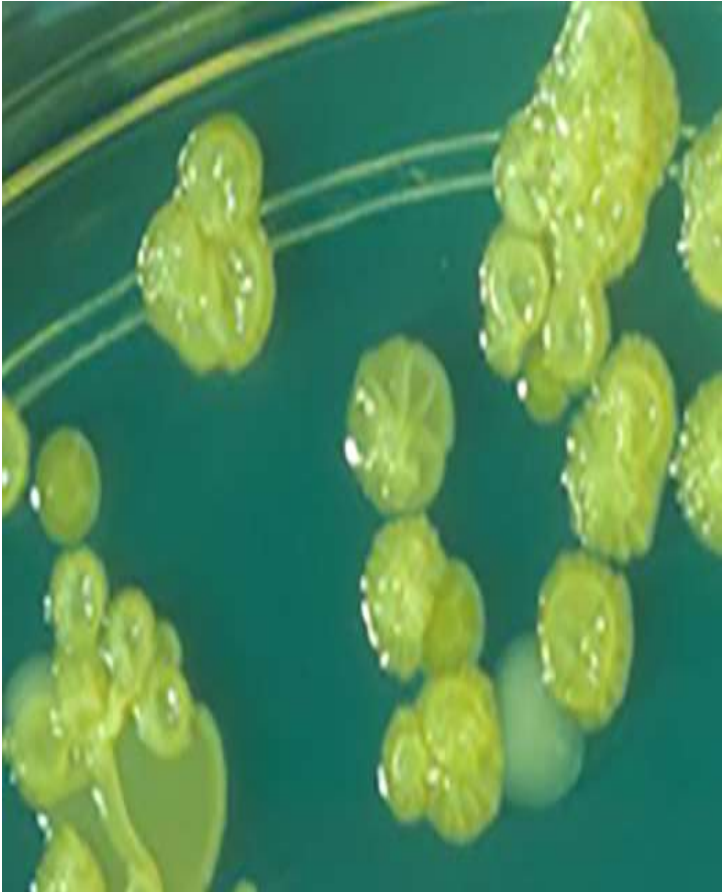
- Bebek formulaları daima soğuk, kapalı bir yerde güneş ışığına doğrudan maruz kalmadan saklanmalıdır.
- Bebek formulası teneke kutuda satılıyorsa, ebeveynler tenekede "eziklik, sızıntı, çıkıntı, kabarıklık, sıkıştırılmış üst veya taban veya nokta halinde pas lekeleri" olmadığını kontrol etmelidir .
- Bunlardan herhangi birinin olması ürünün niteliğinin bozulduğunun ve ürünün güvenli olmadığını belirtisi olabilir

- Bebek formulasının doğru bir şekilde hazırlandığından emin olmak için ebeveynler ve bakıcılar mutlaka formuyla birlikte verilen ölçeği (kaşık) kullanmalıdır.
- Üreticiler arasında formulyı hazırlamak için gereken ölçek boyutu ve sayısının farklı olabileceğine dikkat etmek gerekir.

- Biberonlar üzerindeki ölçü işaretleri her zaman doğru olmayabileceğinden formulanın seyreltilmesi için gereken su miktarını ölçerken ölçü kabı kullanılmalıdır.

- Emzikler ve biberonları çatlama veya yırtılma belirtisi olup olmadığını görmek için düzenli olarak kontrol etmek gerekir.

FORMULA MAMA HAZIRLARKEN SUYUN SICAKLIĐI NE OLMALIDIR??



Dođru formula hazırlamanın
önemli yönü de iyi HİJYENDİR.

Cronobacter sakazakii

- C.sakazakii bebeklerde yaşamı tehdit eden hastalıklara neden olabilecek fırsatçı bir patojenidir.
- Bu patojen ideal sıcaklıkta kısa üreme süresine sahiptir (23 °C'de 40 dakika), bu da sulandırarak hazırlanan bebek **FORMULASININ** üreme için ideal ortam sağladığı anlamına gelmektedir.

Önerilen Su Sıcaklığı

Normal koşullar altında Dünya Sağlık Örgütü formüla hazırlarken sıcaklığı 70 °C'ın altında olmayan suyla sulandırılmasını önermektedir



- Bebeęe verilecek biberon mamasının ısısı 36-37 Derece olmalıdır. Kabaca kolunuza damlattığınız mama size ılık bir his veriyorsa (yakmıyorsa veya soęuk deęilse) uygun ısıdadır.



- Bebek formulasını hazırlarken biberon ve emziklerin kullanımdan önce iyice yıkanması şarttır.
- Kullanım öncesinde yanlış ya da yetersiz temizlenen biberonlar ve emziklerden hastalık kapma riskini minimuma indirmek için 3 aylıktan küçük çocuklarda ekipmanların sterilizasyonu önerilmektedir.

- Ekipmanın düzgün temizlenmesi için biberon ve emzik fırçaları kullanılmalıdır.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010'un raporuna göre Türkiye genelinde bebeklerin **%84.5'nin formüla, %19.5'nin inek sütü** ile beslendiği bildirilmiştir.

- İnsanlık tarihinin başlangıcından beri bebeklerin yapay beslenmesi olagelmektedir. MÖ 2,000'li yıllarda bile bebeklerin beslenmesi için çeşitli hayvan sütlerinin kullanıldığına dair kanıtlara rastlanmıştır. 19. yy sonlarına kadar hayvan sütü yapay beslenmenin en yaygın kaynağıydı.
- Kullanılan sütün tipi etrafta bulunan hayvanların türüne bağlı olarak coğrafik açıdan farklılık gösteriyordu, ancak yapay beslenmede en yaygın olarak kullanılan süt, inek sütüydü.

İNEK SÜTÜ



Modifiye edilmemiş inek
sütü → Solüt yükü fazla



Düşük demir içeriği



Demir eksikliği yüksek

İnek sütü

- ✓ İlk ay → Yarı yarıya
- ✓ 1-4 ay → 2 süt + 1 su
- ✓ %3 bitkisel sıvı (1 çay kaşığı)
- ✓ %5 sofras şekerı (1 tatlı kaşığı)
- ✓ 4 aydan sonra sulandırılmamalı



KARIŞIK BESLENME

- Anne sütünün yetmemesi durumunda veya belli bir aydan sonra anne sütü ile birlikte diğer sütlerin ve ek besinlerin verilmesi şeklindeki beslenmeye **"karışık beslenme"** denir.



TAMAMLAYICI BESLENME

- Tamamlayıcı beslenme, tek başına anne sütünün artık yetmediği dönemde besinsel gereksinimleri karşılamak için anne sütü ile birlikte anne sütü dışındaki gıdaların verilmesidir.



Sağlıklı tamamlayıcı beslenme uygulanmasında 5 şartın yerine getirilmesi gerekir:

**ZAMANINDA,
KALİTELİ,
YETERLİ,
GÜVENLİ,
KEYİFLİ BESLENME**

✓Yarı katı gıdaları ağız boşluğunun arka tarafına aktarmayı ve yutmayı başarır.

17.hafta



26.hafta

TAMAMLAYICI BESLENME



Protein sindiriminin yeterli olmaması nedeniyle proteinler sistemik dolaşıma geçerek, **alerji ve otoimmün hastalık riskini** artıracakı düşünülmektedir

- ✓Emerek beslenme dönemi
- ✓Yutma refleksi zayıf
- ✓Kaşıkla verileni çıkarma eğilimi

Tamamlayıcı Beslenmeye Erken ve Geç Başlamanın Riskleri

Erken Başlama

- Anne sütü yapımı azaltarak yetersiz enerji ve besin alımı
- İshallere yol açarak malnütrisyonu kolaylaştırma
- Akut ishal ve alerjik hastalıkların riskini arttırma
- **Obezite riskini 6 kat arttırma**

Geç Başlama

- Yetersiz enerji ve besin alımına ve malnütrisyonu yol açar.
- Demir ve çinko gibi mikro besin eksiklikleri
- Oral motor fonksiyonlar gecikme
- Yeni tat, lezzet ve besinlere alışması gecikme
- Gıda reddi

Ek gıdalara geçiş dönemindeki bebeğin özellikleri nelerdir?

Sürekli anne sütünü almak ister

- Çiğnemeye gerek yok
- Tertemiz, istenen ısıda
- Annesinin kucağında beslenir

Yeni tatlar istemez

Çiğnemek istemez

**İnatlaşır,
tükürür,
kuser**

**Tatlı yiyecekleri daha çok sever:
Ancak sürekli tatlı vermek diş çürüğü yapar**

Acı sevmez

Annesinin beslenme konusundaki hassasiyetini sonsuza kadar kullanır

Tamamlayıcı Beslenmede Kullanılacak Besin Miktarı

6-8. aylarda

ortalama 200kcal
(2 öğün)



9-11. Aylarda

Ortalama 300kcal
(3 öğün)

12-23. aylarda

550 kcal
(4-5 öğün)

Tamamlayıcı Beslenmede Kullanılacak Besin Miktarı

6-7. aylarda



yumuşak kıvamda ezme
şeklinde

7-8. aylarda



püre şeklinde çok
pütürlü olmayan besinler

8-12. aylarda



kıvam dereceli olarak (püre
kıvamında çatalla ezilmiş
besinler)

- *Yeni besinler aynı zamanda değil, 1-2 Haftalık aralarla verilmeli
- *1-2 çay kaşığı ve tek öğün verilmeli,, bebeğin alımına göre artırılmalı
- *Bebek besini almak istemediğinde zorlanmamalı, daha sonra tekrar denenmeli
- *Besinler kaşıkla verilmeli
- *Besinler doğal ve taze olmalı
- *Besin hazırlanmadan ve bebek beslenmeden önce eller yıkanmalı

- Bebek bir yaşında ise aile yemeklerini yemeğe hazır duruma gelmeli ve aile sofrasında yerini almalıdır



4-6 ayda önerilen tamamlayıcı besinler

ANNE SÜTÜ



- Yoğurt,
- Şekersiz muhallebi
- Sütlaç
- Meyve suyu
- Pekmez
- 6 aydan sonra püre

6-8 ayda önerilen tamamlayıcı besinler

ANNE SÜTÜ



- Yoğurt, muhallebi, sütlaç
- Meyve suyu ve püresi
- Sebze püreleri, sebze çorbası
- Yumurta sarısı (1/4)- 6. ayda
- Yumurta sarısı (tamamı)-7. aydan sonra
- Beyaz peynir
- Et

9-12 ayda önerilen tamamlayıcı besinler

ANNE SÜTÜ



- Yumurta (tam)
- Meyve püresi, sebze çorbası
- Yoğurt, unlu-sütlü mama
- Et, baklagiller (püre 1 öğün)
- Ekmek
- İyi ezilmiş ev yemekleri (kıymalı ve sebze)

İçecekler

- Bitki kökenli çayların farmatoksikolojik etkileri vardır ve bebekler bu maddeye duyarlıdır. Çay ve kahve demir emilimini azaltmaktadır. Bu nedenle bebek ve küçük çocuklar için önerilmemektedir.

- Taze sıkılmış meyve suları bebekler için iyi bir C vitamini kaynağıdır.
- Altı aydan büyük çocuklara günlük 120-180 cc kadar meyve suyu verilebilir.
- Bebeklerde ilk başlanacak meyve suyu kış mevsimi için elma, yaz mevsimi için ise şeftali suyudur.

SU

- Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin ilave suya ihtiyaçları yoktur. Çünkü anne sütünün %88'i sudur ve bebeğin tüm sıvı ihtiyacını karşılamaktadır. Ek gıda dönemine geçmiş bebeklere günlük çeyrek cay bardağını geçmeyecek şekilde su verilmeye başlanmalı, miktar zamanla ve bebeğin ihtiyacına göre arttırılmalıdır.



- ✓ Tamamlayıcı beslenme döneminde bebekler besin değeri yüksek gıdalara (demir ve çinko açısından) yetişkin bir insana göre daha fazla gereksinim duyarlar.
- ✓ Çünkü anne sütü ile beslenen 6-8 ay arasındaki bebeklere yetişkinlere göre 9 kat demire, 4 kat çinkoya daha fazla gereksinim duyarlar.

Tamamlayıcı besinleri ne zaman vermeliyiz?

- Tamamlayıcı besinleri ilk aylarda (6-7 aylar) emzirme sonrası veriniz .Bebeğiniz 8- 9 aylık olduğunda tamamlayıcı besinleri emzirme öncesinde veriniz.
- Böylece emzirme ve tamamlayıcı öğünler yavaş yavaş yer değiştirsede emzirme hala bebeğin beslenmesinde önemli bir yer tutar.

- Tamamlayıcı besinleri hazırlarken şeker ve tuzdan kaçınılmalıdır.
- Bu dönemde şekerli ve tatlı gıdaları tüketilmesi erişkinlikte şekerli ve tatlı beslenmeye eğilimi, obezite ve diş çürüğü risklerini artıracığından dikkat edilmelidir.

Beslenme düzenini sağlamak için nelere dikkat etmeliyiz?

- Bebeğin beslenme alışkanlıkları bu dönemden başlayarak yetişkin hayatındaki tutum ve davranışlarını etkiler.

- Bebeğin neyi ne zaman ne miktarda yiyeceğine bakımını üslenen kişinin karar verdiği katı baskıcı veya her şeyi bebeğe bırakan **kontROLSÜZ yaklaşımlar** yerine çocuğun istek ve eğilimlerine önem veren **duyarlı beslenme denen tutumun benimsenmesi** sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeyi sağlar.

Duyarlı beslenme tutumu nasıl olmalı?

- Bebeğin erken açlık ve tokluk belirtileri takip edilerek beslenmeyi bebeğin başlatması ve yönlendirmesi sağlanır.
- Çocuğun gelişimsel dönemlerine uygun besinler hazırlanır. İhtiyacı olduğunda yardım edilir, parmak gıdalar vb dönemlerde etrafı kirletebileceği endişesi ile kendi kendine yiyebileceği halde kısıtlama yapılmaz.

- İştah artırıcı değişik tat ve şekilde sunumlar ile besinler cazip hale getirilir.
- Sabırlı davranılır, güzel söz ve övgüler ile destek verilir.
- Ne zaman nerde ne yeneceğine ebeveyn ne kadar yiyeceğine çocuğun karar vermesi sağlanır.

- Sizin beslenme alışkanlık ve tutumunuz bebeğinizi de etkileyecektir.
- Beslenmede rol model olduğunuzu göz önünde bulundurarak beslenme tutum ve davranışlarınıza özen gösteriniz.

Besin güvenliği için nelere dikkat etmeliyiz?

- Besin hazırlama sunum ve saklama aşamalarında temizlik kurallarına dikkat ediniz.
- Gıdaları hazırlamadan önce ve sonra, yemekten önce ve sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.

- Kullandığınız malzemelerin(meyve ve sebzeler, tabak, kaşık ,tencere ,bıçak,bardak gibi mutvak gereçleri)temizliğine dikkat ediniz.
- Çiğ ve pişmiş malzemeleri hazırlarken farklı kaplar ve gereçler kullanınız.
- Meyve ve sebzeler çiğ tüketilecekse bol su ile yıkayınız veya kabuklarını soyunuz.

- Tamamlayıcı beslenme de plastik ürünler ve biberon kullanılmamalıdır.
- Kullanılan malzemelerin hijyenini sağlamak için kapların kolay yıkanabilen çelik, cam, porselen olmasına dikkat edilmelidir.
- Meyve püreleri için cam rende kullanılması, çelik rendeye göre vitamin değerlerinin daha az kaybolmasını sağlar.

- Özellikle et, tavuk, balık, yumurta gibi ürünleri iyi pişiriniz.
- Besinleri az miktarlarda hazırlayıp taze olarak tüketmeye özen gösteriniz. Tamamı tüketilmeyen besinleri 10 santigrat derecenin altında saklayınız ve 3 günden fazla bekletmeyiniz.
- Besinlerinizi hazırlarken temiz içme suyu kullanınız.

Daha güvenli besin için anahtarlar

- Yiyecekleri ve kullanılan malzemeleri temiz tutun
- Ayrı pişirin
- İyiye pişirin
- Yiyecekleri güvenli sıcaklıklarda saklayın
- Güvenli su ve taze malzeme kullanın

- Yeşil yapraklı sebze içeren tamamlayıcı besinlerin nitrit miktarının arttırması nedeniyle 1 kereden fazla ısıtmayın
- Fermente süt ürünleri kullanılmalı. Fermente sütlerin(yoğurt ve peynir)raf ömürleri daha uzundur. Ph'larının düşük olması patojen mikroorganizmaların üremesini engeller. Bu açıdan bebek beslenmesinde özel bir yeri vardır.



Niçin bal 12. aya kadar verilmez



İnfant botulizmi: Kabızlık, ekstremite ve vücuda yayılan güçsüzlük, Ölüme yol açabilen belirtiler ile karakterize bir gıda kaynaklı hastalıktır.



- Bu bilgilerin ışığında; ilk altı ay tek başına anne sütü ve altı ay civarında anne sütüne ilave yeterli ve güvenli tamamlayıcı beslenme süt çocukluğu döneminde doğru beslenmenin yoludur.

1-3 yaş Çocuk beslenmesi

- Bu dönem **beslenme alışkanlıklarının** temelini sağlamlaştırıldığı en önemli dönemdir.
- **Öğünler**
- Küçük çocukların düzenli aralıklarla ve büyüklere nazaran daha az miktarda yemeleri uygundur.
- **Kahvaltı - Öğle Yemeği - Akşam Yemeği + 1 - 2 Ara Öğün**
- Öğünler arasında abur-cubur, şekerli içecekler, süt vs. verilmemelidir.
- Su her zaman içilebilir.

- Beraber yemek yemek: Günde en az bir kez aileyle birlikte yemek
- Küçük porsiyonlar sunmak ya da çocuğun miktarı belirlemesine izin vermek
- Yemekleri çocuğa uygun şekilde sunmak (örneğin ufalayarak)
- Yemek esnasında -açık televizyon gibi- oyalanmalardan kaçınmak

- Yemeğe dair hile veya oyunlar yapmamak, vaatlerde bulunmamak
- Çocukları yemeye veya yemeklerini bitirmeye zorlamamak
- Yemek yemeyi ödüllendirme, cezalandırma (yemek vermemek) ya da teselli olarak kullanmamak
- Yemiyorsa o öğünde bulunmayan yiyecekler sunmamak

- Bu yaş grubundaki çocuklar yavaş yerler, etrafı kirletirler ve dikkatleri kolayca dağılır. Bu nedenle çocukların beslenmesi için yeterli zamanın ayrılması gerekir.

- Besinler değişik tat, kıvam, renk ve çeşitlilikte birbirine karıştırılmadan sunulmalıdır.Özel durumlar dışında şekerli besinlerden kaçınılmalı ve ödül olarak verilmemelidir.

- Masada rahat oturabilmesi için uygun boyutta sandalye kullanılmalıdır.Kullandığı kaşık ve çatal da uygun boyutlarda olmalıdır.
- **Çocuk zorla beslenmemeli ve yemek zamanı stresten uzak durulmalıdır.**

- **Ailenin beslenmesini taklit eder**

UNUTULMAMALI

- **Ne görürse onu yapacaktır**
- **Hayat deneyimi henüz yetersizdir**

- Çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesinde anne babanın tutarlılığı ve ona iyi örnek olması en temel koşuldur.



- Sofra oyun alanı değildir. Yemek öncesi ya da yemek sonrası oyun için zaman ayrıldığında, çocuk yemek saatinde yemeği daha iştahla ve sorunsuz yer.

Güvenli besinin en önemli özelliklerinden birisi de hijyenik koşullarda, temiz su ile el yıkandıktan sonra hazırlanmış olmasıdır.



- Konserve gıdalar, hazır çorbalar ve hazır meyve suları, şekerli yogurt ve peynirler, tuzlu ve biberli gıdalar uygun besinler değildir. Sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerin çocuk beslenmesinde yeri yoktur.



Çocuğun yeterli ve dengeli beslendiğinin en iyi göstergesi büyümesinin izlenmesidir.



Kaynaklar

- S.B. Sağlık Eğitimi Genel Md., Eğitimciler için eğitim rehberi, Beslenme Modülleri, Ankara, 2008.
- Balcı E. Anne sütünün çocuk büyüme ve gelişmesi üzerine etkisi. Türk Aile Hek Derg 2011;15(3):135-138.
- World Health Organization. Global strategy for infant and young child feeding: The optimal duration of exclusive breastfeeding, 2013.
- http://www.unicef.org/turkey/search_tu.php?q=bebek+%C3%B6l%C3%BCmleri Erişim Tarihi: 07.04.2015
- Köksal G, Özel HG. Bebek beslenmesi Kitabı, Ankara, 2008;1-32.
- Flores MS, Fairchok MP. The Relationship of breastfeeding to antimicrobial exposure in the first year of life. Clin Pediatr (Phila).2004; 43:631-636.
- U.S. Department of Health and Human Services. Maternal, infant, and child health. HealthyPeople2020;2010.<http://healthypeople.gov/2020/topicsobjectives2020/overview.aspx?topicid=26>. Erişim Tarihi:13.03.2015
- Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması - 2013. Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye
- Yalçın RV. Sağlıklı süt çocuğu beslenmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007, 3(7):116-119.
- Selimoğlu MA. Sağlıklı ve hastalıkta çocuk beslenmesi, Ömür Matbacılık A.Ş, İstanbul 2014
- Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri. 4 rd ed. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2010
- Gür E. Anne Sütü ile beslenme. Türk Ped Arş 2007; 42 Özel Sayı: 11-15.
- Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012;129:827-841.
- Atalay Z, Bereket A. Vitamin D ve Güncel Öneriler. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012;8(2):9-12.
- Jonsdottir OH, Thorsdottir I, Hibberd PL, Fewtrell MS, Well JC, Palsson GI et al. Timing of the introduction of complementary foods in infancy: a randomized controlled trial. Pediatrics 2012; 130:1038-1045.
- Gökçay G, Özden T, Karakas Z, Karabayır N, Yıldız I, Abalı S et al. Effect of iron supplementation on development of iron deficiency anemia in breastfed infants. J Trop Pediatr 2012; 58:481-485.
- Telatar B, Zengin BE, Vitrinel A, Erginöz E. Anne Sütü Alan Bebeklerde 4. Aylık Demir Durumu. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2005;9(4):163-165.
- Berglund S, Domellöf M. Meeting iron needs for infants and children. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2014, 17:267-272.
- Domellöf M, Braegger C, Campoy C, Colomb V, Decsi T, Fewtrell M et al. Iron Requirements of Infants and Toddlers. JPGN 2014;58: 119-129
- Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010. Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Raporu, Ankara.
- Aydın A. Yapay Beslenme ve Ek Gıdalar. Sağlam Çocuk İzlemi Sempozyum Dizisi 2003; 35 :79-84
- Kültürsay N, Terek D. Prematüre Bebeklerde Anne Sütü Zenginleştiricilerinin Kullanımının Yararları ve Pratik Uygulama Önerileri. Ege Pediatri Bülteni. 2010;17(3):137-148.
- Samlı G, Kara B, Ünalın PC, Samlı B, Sarper N, Gökalp AS. Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusundaki bilgi, inanış ve uygulamaları. Marmara Medical Journal 2006;19(1):13-20.
- Sivri BB. 0-6 Aylık Bebeği olan annelerin katı gıdaya geçiş süreci ve emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları. ACU Sağlık Bil Derg 2014(1):59-65.
- Agostoni C, Decsi T, Fewtrell M, Goulet O, Kolacek S, Koletzko B et al. Complementary feeding : a commentary by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46:99-110.
- Gür E. Tamamlayıcı Beslenme. Türk Ped Arş 2006; 41:181-188.
- Lutter CK. Growth and complementary feeding in the Americas. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2012 ;22: 806-812.
- WHO. Complementary feeding: Family foods for breastfed children .France: FSH MediMedia Ltd;2000:1-51.
- WHO. Guiding principles for feeding non breastfed children 6-24 months of age. WHO Press, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2005:1-42.
- Youna BE, Krebs NF. Complementary Feeding: Critical Considerations to Optimize Growth, Nutrition, and Feeding Behavior. 2013; Curr Pediatr Rep. 1: 1(4): 247-

TEŞEKKÜRLER

ndede@sakarya.edu.tr